

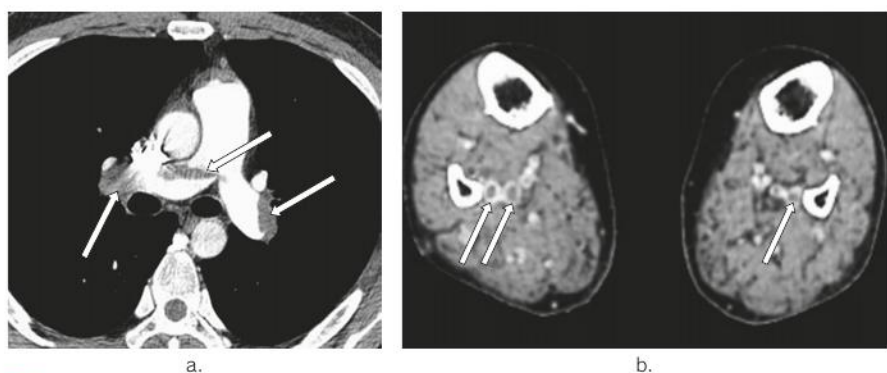


図1 急性肺血栓塞栓症（MDCTA-CTV）
a：胸部（左右主肺動脈に filling defect を認める）
b：下肢静脈〔両側の下腿静脈に filling defect（血栓，矢印）を認める〕

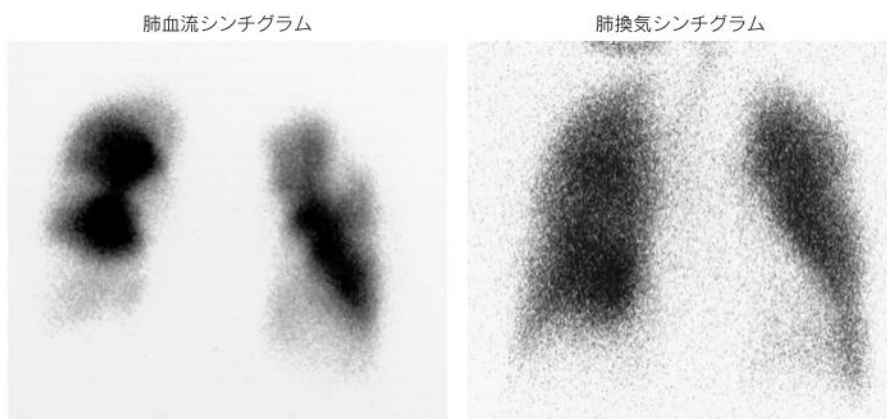


図2 肺血栓塞栓症の肺換気・血流シンチグラム所見

行うことも推奨されている。D-ダイマー $<0.5\mu\text{g/mL}$ であれば、PTEは否定的とされる。胸部X線所見は、典型例では肺動脈拡大や肺野の限局性透過性亢進（Westermarck sign）がみられるが、心拡大など非特異的な変化のみのことも多い。心電図ではS1Q3T3が有名であるが発現頻度は低い。ともに正常でも本症を否定できない。血液ガス所見では低二酸化炭素血症を伴う低酸素血症が特徴である。心エコーでは右室の拡大がみられ、発症状況、臨床症状に加え心エコー上右心負荷所見があれば本症を強く疑う。急性PTEのみでは収縮期肺動脈圧が60 mmHgを超えないと考えられており、超える場合にはacute on chronicのPTEを考慮する。造影CTは本症の確定診断に有用で、中樞側（主肺動脈，葉動脈，区域動脈）の血栓検出においては、感度，特異度とも90%以上とされ（図1），同時に骨盤～下肢を撮影することで，併せてDVTの診断も可能である（図1）。造影剤アレルギーや腎障害のある症例では，肺換気・血流シンチグラムで換気に異常を認めず，区域以上の血流欠損があることで診断される（図2）。下肢DVTの非侵襲的検査として，

下肢静脈エコーも有用である。

b CTEPHの診断

慢性の労作時呼吸困難を呈する患者では，本症を疑うことが重要である。確定診断は，造影CTまたは肺動脈造影で，慢性血栓に特徴的とされる所見を呈することとともに，肺高血圧症を診断することで行う。肺高血圧症の診断は心エコーでスクリーニングを行い，右心カテーテル検査で肺動脈楔入圧正常な肺高血圧症（平均肺動脈圧 $>20\text{ mmHg}$ ，肺動脈楔入圧 $\leq 15\text{ mmHg}$ ）を確定する（図3）。肺動脈性肺高血圧症との鑑別には，肺換気・血流シンチグラムが有用である。

c 肺梗塞の診断

胸背部痛や血痰の症状で本症を疑い，胸部単純CTにおける特徴的な画像所見で診断する。肺野内側を頂点とする楔状，半円状の浸潤影（Hampton's hump），出血性梗塞を反映した梗塞部周囲のすりガラス影，浸潤影内部の低吸収域が特徴的とされる。